2026.8.15–8.16 · 马来西亚场

# 神经重置

## 从感觉、疼痛到日常功能

用感觉与动作的联系读懂两天课程，将局部演示、连续个案和长期功能放在同一张地图中。

**阅读方式**

先看地图，再读主题；用表格比较，用逻辑图串联。正文编号可跳转到出处索引；无需在大段原文中反复寻找。

## 本课目录


01 整门课的地图：从感觉走向生活

02 概念对照：感觉、疼痛与身体认识

03 统一的观察语言：先把问题说清楚

04 区域地图：把零散部位放回整体

05 连续个案：把变化和未解决项放在一起

06 从当场变化到动作学习与日常训练

07 理解课程模型，也看清它的解释范围

08 一张复盘表：把知识用在清楚的记录上


资料范围：45份。各篇主题映射与具体文件页码见书末出处索引。

本书用于课程学习与复盘。课堂模型、现场观察、整理补充和外部核对分别表达；原文与旧版逐篇PDF保留在原资料夹。

# 整门课的地图：从感觉走向生活

课程反复围绕一个问题展开：身体提供的信息、本人感受到的状态，以及实际做出的动作，如何联系起来？讲者用“整合”“不匹配”“脱敏”组织解释，并通过接触、视觉反馈和动作演示观察变化。全局阅读时，可把理论、区域索引、个案和日常训练串成四层。[8.15-01][8.15-02][8.15-03][8.15-11]

**理解层**

辨认中枢与周围、感觉输入与动作表现。先知道每个词在说什么，再讨论它能解释哪些现象。

**观察层**

把“痛、麻、没力、卡住”拆开；每次比较固定一个问题和任务，让前后结果有可比性。

**生活层**

课堂动作变好后，还要回到站立、走路、抓握等原先受影响的任务，并追踪是否保持。

| 阅读层次 | 要回答的问题 | 课程中的连接 |
| --- | --- | --- |
| 概念基础 | 身体怎样接收、理解和回应信息？ | 中枢/周围、身体意象、疼痛调节。[8.15-02][8.15-05] |
| 局部区域 | 课程在哪些区域观察和示范？ | 颈肩、上肢、腰髋、膝踝与足部；区域名称只是回看索引。 |
| 个案比较 | 哪一项变化了，哪一项仍未变化？ | 同一个案可能跨多份文件；需串联基线、各阶段和残余问题。 |
| 功能迁移 | 回到生活后是否更容易完成任务？ | ADL指日常生活活动，站坐差异、负重差异都应保留。[8.15-11] |
| 维持与复盘 | 当场变化是否延续，发生了哪些新情况？ | 次日反馈、复发、训练负荷与生活影响。[8.15-12][8.16-01] |

**描述问题** → **建立基线** → **观察变化** → **回归生活**

具体困扰与生活影响 | 同一个人、同一任务 | 感觉与功能分别看 | 持续性与真实需求

### 把这些内容连起来

整理补充：这四步是一种阅读和记录方法，不是宣称任何症状都能用同一技术处理。“局部舒服”与“生活功能恢复”之间还有一步：重新完成原来困难的任务。例如坐着足部动作减痛以后，站立和走路是否仍痛，需要另测。[8.16-20][8.16-21]

**复习与应用**

复习时先用一句话说出当事人最想改善的生活任务，再解释相关概念。这样可以避免只记点位、产品或即时分数。

# 概念对照：感觉、疼痛与身体认识

“感觉变清楚”“痛减轻”“更能用力”分别属于体验、症状和功能层面。它们可能同时变化，也可能只改变一项。把这几层分开，才能理解课堂演示，而不从单一反馈直接跳到病因结论。[8.15-02][8.15-03][8.15-05][8.15-06]

**中枢与周围**

中枢包括脑和脊髓，周围神经连接身体各处。课程的CPU比喻帮助入门，实际关系包含来回传递与调节。

**身体意象**

闭眼时对身体形状、大小或清晰度的描述，属于主观体验。它不等同于正式的感觉检查。

**疼痛调节**

感觉输入可能改变疼痛体验。疼痛本身是真实的个人体验，需要尊重，不能用“大脑参与”否认它。[E01]

| 概念 | 抓住什么 | 容易混淆的地方 |
| --- | --- | --- |
| 触觉 | 皮肤接触等信息 | 触到哪里，不等于已确定哪里是病因。 |
| 本体感觉 | 身体位置与运动相关信息 | 不等同肌力大小，也不等同闭眼想象是否清晰。 |
| 伤害性感受 | 对可能伤害组织的刺激进行编码 | 与疼痛体验相关，但不能直接画等号。[E01] |
| A类、Aδ与C纤维 | 不同纤维类型和功能的讨论 | 不能整体分成“好神经”和应消除的“坏神经”。[8.15-05] |
| 闸门理论 | 课程用来理解感觉输入与疼痛调节 | “C纤维挡住身体认识”是讲者延伸模型，不能作为所有症状的通用机制。[8.15-05] |
| 不匹配/脱敏 | 讲者用来组织问题与处理的词 | 即时改变不证明已直接测到或修复了某条神经。[8.15-03][8.15-10] |

**输入** → **体验** → **动作** → **反馈**

接触、视觉、位置等信息 → 痛感、身体形象、舒适度 → 范围、力量、任务完成 → 重新记录并比较

### 把这些内容连起来

整理补充：可以同时问“感觉如何”和“能做什么”。例如手指张开更大而仍有手抖，是两项不同结果，不矛盾，也不能把它合写成“手恢复正常”。课堂解释可作为假设，但要证明特定机制，还需要相应测量和对照。[8.15-19][8.15-20]

**复习与应用**

尝试分别解释：疼痛、伤害性感受、触觉、本体感觉、身体意象。能否各给一个课堂例子，而不把它们混成“感觉神经”？

# 统一的观察语言：先把问题说清楚

“腰痛”“手麻”“脑雾”“五十肩”都可能把多种体验压在一个标签里。课程中的有效问诊片段，会回到部位、时间、诱发任务和本人描述；实际记录还应把既往诊断、检查结果和讲者推测分栏保存。[8.15-07][8.16-02][8.16-04][8.16-20]

**本人描述**

让本人说完、指出部位、解释“麻”“卡”“没力”具体指什么。不要由旁观者代答。

**可比条件**

固定姿势、支撑、动作、负重和提问方式。条件不同的分数分别记录。

**结果全貌**

改善、无变化、残余症状和新增不适都进入记录；未测到的项目明确留空。

| 记录项 | 具体写法 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- |
| 主要目标 | “走路时足背痛”，而非笼统“脚不好” | 让后续比较对准最影响生活的问题。[8.16-20] |
| 发生模式 | 何时开始、持续多久、坐站和活动有何差别 | 区分同部位不同场景的困扰。[8.15-11][8.16-05] |
| 感觉类型 | 疼痛、感觉减少、针刺/虫爬、抖动分别写 | 一个“麻”字不能代表完整症状。[8.15-19] |
| 功能任务 | 抓握、张指、弯腰、跪坐、负重行走 | “舒服了”与“能完成”是两种结果。[8.16-18][8.16-19] |
| 既往资料 | 本人自述与实际报告分列；记录用药和手术背景 | 不凭课堂观察重判影像，也不抹掉病史。[8.15-15] |
| 复测时点 | 当场、稍后、次日和之后的生活表现 | 当场评分不等于维持时间。[8.15-11][8.15-12] |

**听取主诉** → **选定任务** → **分步复测** → **延后核查**

用当事人的语言 | 标清条件与基线 | 逐项记录所有结果 | 看生活表现与持续性

### 把这些内容连起来

整理补充：分数必须带着问题一起保存。“3分”如果分别来自坐姿、站立和他人按压，就不是同一把尺子。类似地，正常肌力是一个检查结果，不能替代其他检查；单侧头痛也不自动等同于偏头痛。[8.16-04][8.16-13][8.16-21]

**复习与应用**

一份清楚的结论可以写成：“在相同站姿任务下，当事人自评痛感减轻，走路仍不适；持续时间待追踪。”不要删掉后半句。

# 区域地图：把零散部位放回整体

两天课程从颈肩和上肢，逐步转到腰髋、盆底、下肢及平衡。下面是课程术语与文件的导航图，帮助定位内容；它不是完整神经支配图，也不把某处症状直接等同于某条神经疾病。

**先认区域**

让本人指出部位，区分肩上方、肩关节、后肩及手部等区域。

**再认术语**

辨认课程提及的神经名称，明显错字可校正；节段冲突和“这里”保留待核。

**最后看任务**

回到抬臂、抓握、站立和跪坐等活动，观察区域之间怎样共同参与。

| 课程区域 | 关键词与主要内容 | 关联到的观察任务 |
| --- | --- | --- |
| 颈部/耳周/枕后 | 颈横、耳大、枕小及锁骨上神经；声音、咳嗽与面部案例。[8.15-08][8.15-09][8.15-10] | 转头、抬臂、声音及面部动作；即时反应不能确定病因。 |
| 肩与上肢 | 肩手疼痛、外侧/内侧分组，桡神经沟、胸小肌等课堂位置。[8.15-13][8.15-14][8.15-18][8.15-20] | 拇指活动、张指、握持与手工对抗；施力条件需一致。 |
| 腰背与髋周 | 臀上皮、臀中皮、股外侧皮、髂腹相关及生殖股神经话题。[8.16-06][8.16-09][8.16-12][8.16-13] | 坐站、前后弯腰、压痛及异物感；主观与结构分开。 |
| 胸背与瘢痕 | 脊旁节段、胸部不适、术后压痛。[8.16-14][8.16-15][8.16-16][8.16-17] | 自发痛与触压痛分列；局部减痛不代表内脏或术后结构恢复。 |
| 膝、踝与足 | 隐神经、股外侧皮、腓总和股后皮等课堂回顾。[8.16-18][8.16-21] | 跪坐需膝踝髋腰配合；坐姿与负重结果不能合并。 |
| 枕下与平衡 | 颈部本体感觉、视觉和前庭的课程联系。[8.16-22][8.16-23] | 站立策略、踝部活动与转头诱发症状；多系统共同参与。[E04] |

**症状区域** 哪里、怎样不舒服 → **相关概念** 课程使用哪些词 → **功能任务** 哪些部位共同参与 → **复测结果** 哪一项真正改变

### 把这些内容连起来

整理补充：一张区域表的价值在于找到相关段落，而不是把所有表现装进固定“点位→疾病”的配对。课程将上游与下游比作父子或河流，这有助记忆，但解剖、临床诊断和疗效判断仍是不同层次。

**复习与应用**

选择一个生活任务，说明至少两个可能参与的部位。例如跪坐不仅包含膝屈曲，也涉及踝跖屈、髋腰配合及支撑条件。

# 连续个案：把变化和未解决项放在一起

这些案例分散在多份文件中，整合后更容易看见它们共同的学习价值：明确基线、分阶段观察、保留残余问题。下表按主题串联，均为课堂记录或讲者回顾，不代表已验证的治疗效果。

**比较单位**

同一个人、同一种症状、同一个任务。不能把多人反馈拼成一条成功路径。

**干预数量**

接触、产品、动作、支撑和提示往往同时变化，单一方法的贡献未被分离。

**结局范围**

课堂结束时未解决的项目继续保留；没有随访就不补写长期结果。

| 案例线索 | 课堂中的主要变化 | 对全局理解的帮助 |
| --- | --- | --- |
| 肩手痛与残余手痛 | 前段部分动作8–9分，后述约3分或1–2分；后续另一动作仍约5分。[8.15-13][8.15-14][8.15-19] | 不同任务的分数不能拼成一条精确疗效曲线。 |
| 手麻、手抖跨日复查 | 张指较前增加但仍抖；次晨再次反馈麻、抖及动作限制。[8.15-19][8.15-20][8.16-01] | “复发”需拆成哪些改善保留、哪些再次出现。 |
| 多部位拉扯与耳鸣 | 颈部约6→2分，左右腿变化不同；整体活动更容易，但缺完整终点评分。[8.15-15][8.15-16] | 分左右、分部位记录，不能以整体舒服覆盖残余。 |
| 长期腰痛 | 先建病史和坐站基线，颈部与腰臀分段处理后报告减轻；坐姿更自然。[8.16-05][8.16-06][8.16-07] | 影像标签、当前痛感、任务表现应分别解释。 |
| 膝痛与跪坐 | 走动舒服以后跪坐仍困难，增加腰臀观察、支持及模仿后可下得更低。[8.16-18][8.16-19] | 减痛、活动度和动作学习不是同一个结果。 |
| 足背痛 | 颈部触碰曾无变化；局部处理后部分改善，负重仍有残余痛。[8.16-20][8.16-21] | 阴性结果有价值；坐姿改善还须回到走路。 |
| 面部抽动 | 头位变化与抽动有关；后续报告闭眼减少，仍有少量抽动。[8.15-08][8.16-22][8.16-23] | 触发关联与症状改变均不足以确诊或排除其他病因。 |

**基线** → **过程** → **结果** → **后续**

症状与任务 → 每次改变的条件 → 改善和残余并列 → 生活功能与随访

### 把这些内容连起来

阅读案例时，可先找“没有变化”和“仍然存在”的句子。它们让结果的范围更清楚，也帮助确定下一次真正需要观察的问题。术后瘢痕、盆底下坠或异物感等案例，同样遵守这一逻辑：感受改变不能代替组织检查。[8.16-10][8.16-11][8.16-13][8.16-17]

**复习与应用**

任选一例，用三句话复述：原来哪项任务困难；现场发生了什么变化；结束时仍不知道什么。

# 从当场变化到动作学习与日常训练

课程最终希望把感觉变化带回实际动作。补齐的11号文件明确谈到ADL；次日的跪坐、负重足痛和平衡案例则说明：同一人在不同任务条件下，表现可以不同。训练的目标应写成可观察的生活能力。[8.15-11][8.15-21][8.16-19][8.16-21]

**感觉目标**

痛、紧、麻或陌生感如何变化；描述本人的体验。

**任务目标**

走、站、握、坐等活动能否更自然完成；说明支撑与负重。

**维持目标**

活动之后和次日如何，生活是否更方便；将短时变化与长期保持区分。

| 环节 | 课程中可借鉴的原则 | 扩充理解 |
| --- | --- | --- |
| 选择任务 | 回到原先不舒服的生活情境。[8.15-11] | 复测应在可耐受范围内进行，不等于反复制造疼痛来证明有效。 |
| 降低难度 | 从有支持或较容易的动作开始，再看能否完成。[8.16-19] | 记录支持条件，才能知道是任务变简单，还是能力改变。 |
| 反馈学习 | 视觉、模仿及重复尝试可被纳入观察。[8.15-03][8.16-19] | 一次表现包含熟悉任务、注意与提示等因素，不能只归因手法。 |
| 心肺与力量 | 课程反复提倡结合两类活动。[8.15-21][8.16-24] | 一般成人可参考每周150–300分钟中等强度，或75–150分钟高强度有氧，并安排肌力活动。[E02] |
| 强度与恢复 | 写清活动类型、强度、时长、频率及练后反应。 | 4×4属于特定高强度框架；相关资料采用85%–95%最大心率，不能照搬课堂100%目标。[8.16-24][E09] |
| 个体差异 | 保留疲劳、头晕、术后限制及活动后恶化的反馈。[8.16-02][8.16-23] | 训练安排随健康背景和耐受调整，不按年龄、性别或器械名称一概判断。 |

**选生活目标** → **确认可完成范围** → **观察训练反应** → **再调整安排**

一个具体任务 → 支持、幅度与负荷 → 症状、功能与恢复 → 依据实际反馈

### 把这些内容连起来

整理补充：功能迁移可用三层理解——课堂能完成、不同条件能完成、日常持续能完成。这是对案例的归纳，不是额外制定的康复处方。水中活动、力量训练和间歇训练提供不同任务条件，讲者个人偏好不能取代个体选择。[8.16-24]

**复习与应用**

把“加强运动”改写为一份可讨论的记录：活动目标、现有能力、采用的任务、观察哪些反应，以及何时复盘。不要只写一个运动名称。

# 理解课程模型，也看清它的解释范围

“变化很快”说明变化发生在短时间内；它本身不能证明唯一病因、确定神经定位或预测维持多久。课程中的生理概念、机制假设、个案回顾、产品主张和商业经验，需要放在不同层级阅读。[8.15-04][8.15-10][8.15-11][8.16-03]

### 概念与模型

先确认定义，再看讲者如何使用。模型能帮助提问，不自动成为每个个案的结论。

### 观察与机制

“处理后感觉轻松”是观察；“关闭了某种纤维”是机制解释，二者需要不同证据。

### 经验与推广

个体回忆不能给出普遍有效率。产品说明、资历和客户复购也不能代替比较研究。

| 课堂延伸话题 | 全局笔记中的定位 | 进一步理解 |
| --- | --- | --- |
| 膏剂与激光 | 保留为讲者的产品/技术主张。[8.15-10][8.15-11][8.16-03] | 现有材料未提供足够成分、参数、对照及不良反应资料，不能组成治疗方案。 |
| 面食、奶与小脑 | 属于未证实的通用因果推断。[8.15-16][8.15-17] | 乳糜泻等具体疾病有诊断路径；不能推广到所有人，先去除麸质可能影响检查。[E08] |
| 年龄、性格与疗效 | 属于讲者解释，缺少比较资料。[8.15-11] | 疗效差异不能用来判断一个人固执、脑退化或不配合。 |
| “摸后好转”排除病变 | 不能成立为诊断排除规则。[8.15-08][8.16-14] | 症状缓解与是否需要进一步检查，是两个问题。 |
| 盆底、痔疮、术后问题 | 课堂有下坠感和压痛改变。[8.16-09][8.16-10][8.16-17] | 感觉收紧不等于组织复位；局部减痛不代表手术没有必要。 |
| 皮肤反应与接触边界 | 操作后反应和个人触碰意愿应分别记录。[8.16-08] | 未见即时反应不能排除后续问题；不愿被触碰不等于人格或神经异常。 |

**识别主张** → **找对应证据** → **检查跨度** → **保留结论边界**

它具体断言什么 | 观察、检查还是研究 | 是否超出证据范围 | 未知明确写未知

### 把这些内容连起来

整理补充：这不是给课程所有内容贴统一标签，而是让每条信息各得其所。区域名词用于定位阅读，案例用于学习观察，权威资料用于校正基础概念。尚未核实的论文、百分比和口述术语，不以流畅表达补成确定事实。

### 复习与应用

遇到“百分之百”“所有问题”“一次解决”时，追问其对象、测量指标、比较条件和随访时间。四项缺失时，不把它写进客户的效果承诺。

# 一张复盘表：把知识用在清楚的记录上

以下是根据两天课程归纳的学习记录模板。它用于课程复习和沟通，不是诊断量表。一次只聚焦一个主要问题，将实际观察与解释分开，最后回到本人最在意的生活影响。[8.15-07][8.15-11][8.16-07][8.16-20]

**学习前**

选一个主题，写出已有理解与最想回答的问题。无需一次记住全部神经和区域。

**阅读时**

先看概念，再追踪一个连续个案；遇到跨文件的片段，用出处编号接回前后。

**复盘后**

用自己的话解释主线，标出能确认的结果、尚缺的信息和需要继续查证的问题。

| 记录栏 | 可以填写的内容 | 检查问题 |
| --- | --- | --- |
| 主要困扰 | 部位、开始时间、本人描述、生活影响 | 我是在记录本人体验，还是提前替他下结论？ |
| 目标任务 | 具体动作、姿势、负重与支撑条件 | 后面能否在相同条件下再观察？ |
| 基线 | 症状评分、动作表现、已有检查分别记 | 每个分数对应哪个症状和任务？ |
| 过程 | 依次发生了哪些变化、由谁实施 | 是否有多个环节同时改变？ |
| 即时结果 | 改善、未变化、残余与新增不适 | 有没有只挑好看的结果？ |
| 后续记录 | 当日/次日/生活场景的反馈，未得知则留空 | 是否把预测写成已经发生？ |
| 解释与来源 | 课程解释、自己的问题、文件编号 | 结论是否超过现有资料？ |

**回忆概念** → **读懂个案** → **填写记录** → **核查出处**

用自己的话解释 | 按时间线串联 | 固定任务和指标 | 回到具体文件

### 把这些内容连起来

跨课题连接：本课的“感觉—动作—生活功能”框架，在女性脑科学里会扩展到睡眠、压力、消化、排尿和性健康。共同的是记录方法；不同主题仍有各自的专业知识与评估路径，不能因为共用感觉语言就合并成同一种疾病。

### 复习与应用

完成自测：①区分体验与结构；②解释一次减痛为何不等于治愈；③举例说明不同任务不能混评分；④说明ADL的意义；⑤指出一个未核实的课堂主张及其缺少的证据。

# 课程出处索引

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.15-01] 课程导入与问题意识**

独立PDF：01_课程导入与问题意识_笔记与原文.pdf
8.15/1.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第4页

**[8.15-02] 中枢、周围与身体意象**

独立PDF：02_中枢、周围与身体意象_笔记与原文.pdf
8.15/2.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第8页

**[8.15-03] 感觉反馈与视觉演示**

独立PDF：03_感觉反馈与视觉演示_笔记与原文.pdf
8.15/3.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第12页

**[8.15-04] 疼痛解释与证据意识**

独立PDF：04_疼痛解释与证据意识_笔记与原文.pdf
8.15/4.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第16页

**[8.15-05] 感觉纤维与闸门理论**

独立PDF：05_感觉纤维与闸门理论_笔记与原文.pdf
8.15/5.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第20页

**[8.15-06] 伤害性感受与敏化**

独立PDF：06_伤害性感受与敏化_笔记与原文.pdf
8.15/6.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第24页

**[8.15-07] 主观症状与功能评估**

独立PDF：07_主观症状与功能评估_笔记与原文.pdf
8.15/7.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第28页

**[8.15-08] 颈部感觉分支与面部案例**

独立PDF：08_颈部感觉分支与面部案例_笔记与原文.pdf
8.15/8.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第31页

**[8.15-09] 颈部触觉与腰痛咳嗽案例**

独立PDF：09_颈部触觉与腰痛咳嗽案例_笔记与原文.pdf
8.15/9.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第35页

**[8.15-10] 颈部练习与产品说明**

独立PDF：10_颈部练习与产品说明_笔记与原文.pdf
8.15/10.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第39页

**[8.15-11] 效果维持与生活功能**

独立PDF：11_效果维持与生活功能_笔记与原文.pdf
8.15/11.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第43页

**[8.15-12] 效果维持与社区分享**

独立PDF：12_效果维持与社区分享_笔记与原文.pdf
8.15/12.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第46页

# 课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.15-13] 锁骨上神经与肩手疼痛**

独立PDF：13_锁骨上神经与肩手疼痛_笔记与原文.pdf

8.15/13.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第51页

**[8.15-14] 肩手案例复测与肩部无力**

独立PDF：14_肩手案例复测与肩部无力_笔记与原文.pdf

8.15/14.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第55页

**[8.15-15] 多部位不适个案与基线**

独立PDF：15_多部位不适个案与基线_笔记与原文.pdf

8.15/15.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第59页

**[8.15-16] 多部位个案的阶段反馈**

独立PDF：16_多部位个案的阶段反馈_笔记与原文.pdf

8.15/16.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第63页

**[8.15-17] 饮食观点与证据边界**

独立PDF：17_饮食观点与证据边界_笔记与原文.pdf

8.15/17.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第67页

**[8.15-18] 上肢外侧主题与示范**

独立PDF：18_上肢外侧主题与示范_笔记与原文.pdf

8.15/18.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第71页

**[8.15-19] 残余手痛与麻木手抖**

独立PDF：19_残余手痛与麻木手抖_笔记与原文.pdf

8.15/19.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第75页

**[8.15-20] 上肢内侧主题与复测**

独立PDF：20_上肢内侧主题与复测_笔记与原文.pdf

8.15/20.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第79页

**[8.15-21] 训练复盘与课程收束**

独立PDF：21_训练复盘与课程收束_笔记与原文.pdf

8.15/21.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第83页

**[8.16-01] 手部症状的复测与身体感知**

独立PDF：01_手部症状的复测与身体感知_笔记与原文.pdf

8.16/1.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第3页

**[8.16-02] 晨间状态、脑雾与运动讨论**

独立PDF：02_晨间状态、脑雾与运动讨论_笔记与原文.pdf

8.16/2.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第7页

**[8.16-03] 神经系统视角与课程适用范围**

独立PDF：03_神经系统视角与课程适用范围_笔记与原文.pdf

8.16/3.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第11页

# 课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.16-04] 头痛术语与腰痛范围**

独立PDF：04_头痛术语与腰痛范围_笔记与原文.pdf

8.16/4.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第15页

**[8.16-05] 长期腰痛案例：先听病史**

独立PDF：05_长期腰痛案例：先听病史_笔记与原文.pdf

8.16/5.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第19页

**[8.16-06] 腰痛案例：分阶段观察变化**

独立PDF：06_腰痛案例：分阶段观察变化_笔记与原文.pdf

8.16/6.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第23页

**[8.16-07] 案例收尾与沟通边界**

独立PDF：07_案例收尾与沟通边界_笔记与原文.pdf

8.16/7.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第27页

**[8.16-08] 皮肤反应与接触不适案例**

独立PDF：08_皮肤反应与接触不适案例_笔记与原文.pdf

8.16/8.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第30页

**[8.16-09] 从敏感案例转入盆底讨论**

独立PDF：09_从敏感案例转入盆底讨论_笔记与原文.pdf

8.16/9.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第34页

**[8.16-10] 盆底与痔疮感的课堂示范**

独立PDF：10_盆底与痔疮感的课堂示范_笔记与原文.pdf

8.16/10.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第38页

**[8.16-11] 盆底讨论收尾：体验不等于诊断**

独立PDF：11_盆底讨论收尾：体验不等于诊断_笔记与原文.pdf

8.16/11.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第42页

**[8.16-12] 髋周不适与感觉区域梳理**

独立PDF：12_髋周不适与感觉区域梳理_笔记与原文.pdf

8.16/12.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第44页

**[8.16-13] 髋周与耻骨区域案例复测**

独立PDF：13_髋周与耻骨区域案例复测_笔记与原文.pdf

8.16/13.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第48页

**[8.16-14] 胸部不适与脊旁示范**

独立PDF：14_胸部不适与脊旁示范_笔记与原文.pdf

8.16/14.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第52页

**[8.16-15] 脊旁示范的简短补充**

独立PDF：15_脊旁示范的简短补充_笔记与原文.pdf

8.16/15.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第56页

# 课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.16-16] 脊旁节段、平衡与瘢痕问答**

独立PDF：16_脊旁节段、平衡与瘢痕问答_笔记与原文.pdf

8.16/16.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第58页

**[8.16-17] 乳腺术后瘢痕痛案例**

独立PDF：17_乳腺术后瘢痕痛案例_笔记与原文.pdf

8.16/17.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第62页

**[8.16-18] 膝痛与跪坐：建立功能基线**

独立PDF：18_膝痛与跪坐：建立功能基线_笔记与原文.pdf

8.16/18.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第66页

**[8.16-19] 膝痛复测与动作再学习**

独立PDF：19_膝痛复测与动作再学习_笔记与原文.pdf

8.16/19.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第70页

**[8.16-20] 青年足背痛：会诊式问诊**

独立PDF：20_青年足背痛：会诊式问诊_笔记与原文.pdf

8.16/20.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第74页

**[8.16-21] 足背痛案例：负重与非负重复测**

独立PDF：21_足背痛案例：负重与非负重复测_笔记与原文.pdf

8.16/21.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第78页

**[8.16-22] 平衡观察与枕下示范**

独立PDF：22_平衡观察与枕下示范_笔记与原文.pdf

8.16/22.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第82页

**[8.16-23] 面肌痉挛复测与课末问答**

独立PDF：23_面肌痉挛复测与课末问答_笔记与原文.pdf

8.16/23.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第86页

**[8.16-24] 运动问答与课程结束**

独立PDF：24_运动问答与课程结束_笔记与原文.pdf

8.16/24.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第90页

# 外部核对与阅读说明

### [E01] IASP｜疼痛定义与术语

疼痛是个人体验，不能仅从组织或神经信号推断。

https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/

### [E02] WHO｜身体活动与久坐指南

一般成人有氧及肌力活动建议；不等于个体运动处方。

https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789240014886

### [E04] NIDCD｜平衡障碍

平衡涉及多个系统，评估和康复应个体化。

https://www.nidcd.nih.gov/health/balance-disorders

### [E08] NIDDK｜乳糜泻诊断

诊断结合病史与检查；先自行去除麸质可能影响结果。

https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/celiac-disease/diagnosis

### [E09] NTNU CERG｜运动建议与4×4间歇

相关4×4框架采用85%至95%最大心率，不要求达到100%。

https://www.ntnu.edu/cerg/advice

## 整理口径

课程模型用于准确呈现讲者的思路；课堂观察只说明现场发生的变化；整理补充用于解释联系与阅读方法；外部核对以E编号标注。图中的箭头表示概念关系或复盘顺序，不自动代表已经证实的生理因果。依赖现场图像的手法不从残缺转写补成操作教程。

引用说明：以客户提供的课程标题与日期归档。课堂来源指向已生成的结构化笔记；外部核对仅用于对应基础知识与关键边界，不表示相关机构认可课堂技术。没有可统一核验的录音时间戳，因此不编造分钟定位。

版本：2026-10-30。8.15的11号文件已补齐；全部118份材料均完成通读与主题映射。原始资料未改动，公开版不附原文、个人身份或私人经历细节。

2026.8.27–8.29

# 女性脑科学

## 身体感知与女性健康的整体地图

连接身体感知、压力与睡眠、周期、消化、盆底和亲密体验，跨三天读懂课程的整体脉络。

**阅读方式**

先看地图，再读主题；用表格比较，用逻辑图串联。正文编号可跳转到出处索引；无需在大段原文中反复寻找。

## 本课目录


01 三天课程的整体地图

02 身体感知：输入、体验与功能的区别

03 压力与睡眠：把笼统困扰拆成具体模式

04 月经与内分泌：用时间线读懂变化

05 感觉与动作演示：按目的理解不同方法

06 消化、胸壁与瘢痕：分开感受、外观和功能

07 盆底与排尿：三个问题，一条协调链

08 性健康与身体接纳：以本人体验为中心

09 跨文件案例：看见连续过程与不同结局

10 把课程串成可复习、可讨论的知识体系


资料范围：73份。各篇主题映射与具体文件页码见书末出处索引。

本书用于课程学习与复盘。课堂模型、现场观察、整理补充和外部核对分别表达；原文与旧版逐篇PDF保留在原资料夹。

# 三天课程的整体地图

课程将女性不同生命阶段的身体变化，与感觉、动作、压力和生活体验联系起来。三天内容虽然按现场问答推进，但整理后可沿“认识身体→理解状态→区分具体功能→观察变化”阅读。神经系统是讲者采用的主要视角，身体、关系和医疗背景仍需共同保留。[8.27-01][8.27-02][8.27-03]

**身体发生什么**

月经、孕产、哺乳、手术与年龄阶段可能改变身体和日常需求；每个人的经历与恢复速度不同。

**本人怎样体验**

身体形象、疼痛、疲劳、睡眠、尿意及亲密体验需由本人描述，不用性别概括替代个体信息。

**实际影响什么**

把体验联系到睡觉、进食、行走、排尿、运动与关系中的具体困难，再选择相应主题。

| 主题 | 核心问题 | 三天资料的连接 |
| --- | --- | --- |
| 身体感知与平衡 | 我怎样感到身体的位置、状态和动作? | 8.27的感觉与演示，连接8.29的头眼、节拍和动作案例。 |
| 压力与睡眠 | 外界要求、个人资源和睡眠表现怎样相互关联? | 8.27自主神经导入，8.28睡眠/情绪案例，8.29次日反馈。 |
| 月经与内分泌 | 周期、症状与检查如何放在同一时间线上? | 8.28内分泌框架，联系孕产经历与收尾出血问答。 |
| 消化、胸壁与术后感受 | 痛、胀、外观和组织变化怎样区分? | 8.27腹部个案，8.28肋间与乳房观察，8.29瘢痕案例。 |
| 盆底、储尿与排尿 | 尿意、漏尿和排空分别发生了什么? | 8.28未完成的排尿主题，接8.29演示和系统复盘。 |
| 性健康与身体接纳 | 困扰出在哪个环节，本人有哪些需要与意愿? | 8.29阶段框架、疼痛/感觉问答及身体接纳收尾。 |

**生命与生活背景** → **具体感受** → **功能表现** → **复盘与支持**

阶段、经历、支持与需求 | 用本人语言说明 | 睡眠、动作、排尿等 | 分项观察，选择相应路径

### 把这些内容连起来

整理补充：这张地图表达各主题的阅读关系，不意味着一个脑区或一种手法能统一解释所有女性健康问题。课堂的共同方法是先收集体验，再看功能；每个主题还需要自己的定义、指标和证据。学习可先从最相关的两三个问题入手，再补齐概念。[8.27-01]

**复习与应用**

先选一个真实学习目标，例如“区分尿急和漏尿”或“看懂睡眠案例”。沿地图找概念、案例和复盘表，避免被现场顺序牵着走。

# 身体感知：输入、体验与功能的区别

闭眼身体形象、镜像观察、轻触与平衡练习，贯穿了三天课程。理解这些演示，需要同时记录感觉来源、观察条件和本人反馈。身体形象模糊、漂浮或左右不同，属于当时的体验，不是自动对应某种病变的诊断图。[8.27-10][8.27-11][8.27-12]

### 外部与接触信息

视觉、听觉、触觉等帮助认识环境与身体。镜像和手机影像改变了可获得的信息。

### 位置与运动信息

本体感觉与前庭相关信息参与姿势和动作；课堂把它们与稳定、身体位置感联系起来。[8.28-09]

### 内部状态体验

内感知（interoception）关注内部状态的感受。胀感、心跳感和尿意要与实际器官功能分开记录。[8.27-24]

| 概念或现象 | 如何理解 | 记录要点 |
| --- | --- | --- |
| 触觉与本体感觉 | 皮肤接触信息与身体位置/运动信息各有侧重 | 力量、接触感和位置感不能互相替代。[8.28-09] |
| 身体意象/身体感受 | 对身体形状、边界和清晰程度的主观报告 | 保留本人比喻，不把“香蕉形”“漂浮”变成疾病名称。[8.27-11][8.27-12] |
| 视觉反馈 | 观看自己的影像或动作，可能改变注意与体验 | 注明镜像、睁闭眼及姿势条件。[8.27-03][8.27-10] |
| 姿势与支撑 | 坐姿、仰卧、脚落地与被支持时的体验可不同 | 先对齐条件，再比较分数。[8.27-10][8.27-11] |
| 痛与不适 | 是真实的个人体验，不能被“脑参与”否定 | 与功能、情绪和既往伤病分别记录。[8.28-05][E01] |
| 主动与被动表现 | 自己做和他人辅助做的动作条件不同 | 差异提供观察线索，不能单独排除结构问题。[8.29-17] |

**输入条件** → **本人体验** → **任务表现** → **同条件复测**

视觉、接触、姿势与支持 | 清晰度、舒适度与症状 | 能否完成，如何完成 | 记录变化及不确定性

### 把这些内容连起来

整理补充：一个人“感觉身体更完整”，并不直接意味着肌力增加、病灶消失或睡眠已改善。这些结果需要各自测量。把“体验—功能—结构”画成三列，能避免用最容易得到的主观反馈替代最想证明的临床结果。

### 复习与应用

把“感觉好多了”改成具体描述：哪一部位、哪一种感觉、什么姿势下发生变化；再单独记录对应动作是否改变。

# 压力与睡眠：把笼统困扰拆成具体模式

课程用“挑战与资源”理解压力，也讨论活动与休息的切换。这个视角有助于盘点负荷、休息和支持，但不能把现实伤害或关系问题归咎于本人身体差。睡眠则需要独立记录入睡、夜醒、睡眠机会和白天影响。[8.27-08][8.27-09][8.28-10][8.28-11]

**外界要求**

学习难度、工作节奏、家庭期待及关系处境。发生过的伤害和持续压力不能被一个身体解释抹去。

**可用资源**

休息、能力、支持、选择空间和既往经验。课程中的“个人资源”可扩展为环境与社会支持。

**当下反应**

紧张、疲劳、手汗、身体感受与睡眠分别记，不从一种反应推断全部激素或脑区状态。

| 表现或主题 | 值得问清什么 | 与课堂材料的联系 |
| --- | --- | --- |
| 难入睡 | 是否有足够睡眠机会，何时上床，多久入睡 | 与主动玩手机到很晚分开。[8.28-10] |
| 反复醒/睡得浅 | 夜醒次数、清醒多久、能否再睡、环境与饮品 | “一晚都醒着”是主观睡感，不能直接算出睡眠时长。[8.28-10] |
| 学习后疲劳 | 内容太陌生、难度过高，还是连续信息过量 | 调整学习段落与复盘节奏，不直接解释为脑供血不足。[8.27-08] |
| 事件引发情绪 | 针对什么事件，当前感觉与本人意愿是什么 | 身体舒服与事件影响减轻不是同一个结果。[8.28-06][8.28-07] |
| 声音不适 | 声音类型、强度、触发症状及是否出现耳痛 | 有耐受改变，也有负面反馈，不能只记正向结果。[8.28-12][8.28-13] |
| 次日反馈 | 实际睡眠表现与白天状态，有无其他变化 | 8.29有人自述昨夜睡得较好，未形成可归因的长期随访。[8.29-01] |

**明确困难** → **补充背景** → **分别观察** → **追踪变化**

入睡、夜醒或主动延迟 → 作息、饮品、环境与支持 → 睡眠、情绪、身体体验 → 次日与之后，保留其他因素

### 把这些内容连起来

整理补充：课堂在操作后预测“今晚会睡好”，只是一项待验证预期；只有实际夜间记录才能回答。即使次日有人说睡得好，也不能将多人零散反馈拼成同一个案的完整结果，更不能宣称创伤或抑郁已被现场解决。[8.28-13][8.28-20][8.29-01]

**复习与应用**

复盘时分开写三句话：“当时身体如何”“对事件的感受如何”“当晚睡眠如何”。若某项没有资料，保留为空。

# 月经与内分泌：用时间线读懂变化

内分泌部分的核心是分清调节层次与不同通路：下丘脑、垂体与相应靶腺之间存在信号和反馈关系；压力、生殖与甲状腺话题不能画成同一条单向路线。具体问题仍需回到周期、症状、检查和用药背景。[8.28-01][8.28-02][8.28-03]

**调节轴分开看**

课程讨论下丘脑—垂体—肾上腺与下丘脑—垂体—卵巢两条主线。可以相互影响，但承担不同功能。

**周期按本人记录**

记录出血首日、间隔、持续天数、量与痛感，比较本人以往模式。28天不是人人必须达到的标准。[E06]

**检查带背景读**

保留实际报告、单位、参考范围、周期时点和用药信息；不凭一个数值或一句“有月经”下结论。

| 主题 | 整合后的理解 | 需要保留的信息 |
| --- | --- | --- |
| 周期变化 | 月经是一个时间过程；一次提前或推迟不能说明唯一病因 | 实际日期、连续趋势、疼痛、经量与生活影响。[8.28-02] |
| 压力与生活 | 可与周期一同观察，但不能用安全感统一解释所有变化 | 工作、休息、身体状态及其他同期变化。[8.28-03][8.28-04] |
| 多囊相关话题 | 经期稀发、多毛等是需要进一步了解的线索 | 诊断依据和其他可能原因，不以爱吃甜食代替评估。[8.28-02] |
| 甲状腺话题 | TSH、T3、T4及抗体各有含义，不能共用一个阈值 | 具体检验项目、单位、参考范围和既往结果。[8.28-03] |
| 备孕、手术与内膜 | 结构、激素、症状与周期阶段分开理解 | 原始超声、手术资料、病史与检查时点。[8.28-03][8.28-04] |
| 持续出血与节育环 | 收尾问答是独立健康问题，不能统一归为神经感觉 | 出血模式、器具型号/使用时间及专业评估需求。[8.29-23] |

**记录日期与症状** → **比较个人模式** → **加入检查背景** → **提出具体问题**

先得到真实时间线 | 看变化而非单一标准 | 时点、单位、用药 | 交给相应评估路径

### 把这些内容连起来

整理补充：月经记录的价值，是把“最近不正常”变成可以讨论的趋势。一般信息中，NHS列出常见成人周期21–35天，但个人阶段与变化仍需结合理解；日历也不能保证排卵或避孕安全。本笔记不沿用课堂固定受孕日或“血量越多越好”的说法。[8.28-01][8.28-02][E06]

### 复习与应用

复习图可画成三条并列线：周期日期、身体症状、生活与检查事件。线之间的重合提示值得问的问题，并不自动证明因果。

# 感觉与动作演示：按目的理解不同方法

三天演示可以按观察目的分组：稳定反应、面部触觉与转头、全身开合配合、头眼配合、镜像及手指节拍。下面整理的是各类演示的意图和反馈维度；动作名称、成人反射判定及部分术语尚有不确定处，不补成独立操作程序。

**先看目的**

想观察稳定性、触觉反应、动作配合，还是对身体的感受？目的不同，不能共用一个“有效”指标。

**再看条件**

姿势、视线、支撑、主动/被动、辅助者及节奏，都会改变任务本身。

**最后看耐受**

能完成多少、是否害怕、疲劳、疼痛或头晕，都属于结果，而非必须熬过的过程。

| 课堂类别 | 希望观察什么 | 应怎样读反馈 |
| --- | --- | --- |
| 前庭相关演示 | 接受重心变化时的稳定与身体感受 | 先看基础能否完成；向前或向后倒不能直接诊断病因。[8.27-13][8.27-15] |
| 觅食反射相关 | 面部触觉反应及转头体验 | 痒、抽动或脸手差异不是已经验证的成人诊断标准。[8.27-16][8.27-17][8.27-20] |
| 惊吓/Moro相关 | 头、眼与全身开合的配合 | 名称具体所指待核；受痛与支持条件影响，保留未完成与加重。[8.27-18][8.27-19][8.27-20] |
| 头眼配合 | 注视、头部运动与原有活动表现 | 腰部轻松、坐骨仍不适、眼酸疲劳分别写。[8.29-15][8.29-16] |
| 镜像与分级动作 | 身体体验、动作信心与尝试能力 | 多种反馈同时出现，不能单独归因一种技术。[8.29-18][8.29-22] |
| 手指节拍 | 节律完成、注意与身体感受 | 约94拍为课堂设置；顺序前后有变化，疲劳/手抖/烦躁也需记录。[8.29-20][8.29-21][8.29-23] |

**明确观察目标** → **选择可完成条件** → **记录全部反馈** → **回到原问题**

先定义何为变化　支持与挑战匹配　包含无效和新不适　而非只检查动作次数

### 把这些内容连起来

整理补充：分级的逻辑是“先能舒适完成，再讨论增加要求”。它不等于统一次数、速度或固定器械。儿童与成人的目标及条件不同；下颌、言语和成人反射问题不能仅因名称相近就套用另一门课的动作。[8.27-21][8.27-22][8.27-23] 平衡障碍也可能涉及不同原因，需要个体化评估。[E04]

### 复习与应用

为一项演示写出四个词：目的、条件、反馈、缺口。若无法写清条件，就把它作为回看现场视频的线索，而不作为照做教程。

# 消化、胸壁与瘢痕：分开感受、外观和功能

这组主题的共同问题是：本人感觉到的痛、胀、凉、紧，与组织结构或器官功能是什么关系？课程提供了腹部接触、肋间区域、乳房外观和术后瘢痕的现场观察。把指标分开，可以保留案例价值，同时避免用颜色或一次压痛变化替代功能判断。

[8.27-24][8.28-16][8.28-17][8.29-03]

**症状层**

“胀”可能指胀感、可见腹围变化或反复嗳气；“胃痛”先具体为上腹哪里、何时不适。

**外观层**

颜色、大小、温度感受灯光、角度、接触与身体阶段影响；描述变化前先固定条件。

**病史与功能层**

食物反应、既往检查、手术及用药各有时间线。感受变化不能独立证明器官恢复或病变消失。

| 主题 | 整合后的记录方法 | 课程提示与局限 |
| --- | --- | --- |
| 腹胀与嗳气 | 分开胀感、嗳气、排气、排便；写明持续时间和进食关联 | 8.27腹部个案约10分降到5–6分，但姿势、支持和操作多次改变。[8.27-24][8.27-25] |
| 冷饮或食物后不适 | 记录具体食物、温度、量、出现时间及其他因素 | 不能因别人耐受就否认本人，也不通过强行刺激验证理论。[8.28-14][8.28-15] |
| 肋缘/肋间触碰 | 位置、施力者、诱发反应与即时变化分项记 | 现场有痛、凉、恶心，也有减轻和变胀；这些不能互相覆盖。[8.28-16][8.28-19][8.28-21] |
| 乳房与乳晕 | 将颜色、大小、舒适度分别记录，控制灯光和角度 | 外观不能推断性经历、品行或内脏供血；本人意愿优先。[8.28-17][8.28-18] |
| 旧瘢痕与术后不适 | 手术背景→症状出现→当前触感/动作→后续变化 | 红白颜色不能独立判断炎症；先后关系不等于因果。[8.29-03][8.29-22] |
| 食欲、产品与持续性 | 记录实际进食、同步使用的产品及随访 | 食欲增加自述、复购和产品说明不能充当普遍疗效数据。[8.28-18][8.28-21] |

**具体描述** → **核对病史** → **固定比较条件** → **分层解释**

位置、感觉、诱因与时间 | 检查、手术和用药 | 姿势、接触与环境 | 体验、外观、功能分别看

### 把这些内容连起来

整理补充：若一个案例在不同姿势下反复评分，应画“条件与反馈表”，而非仅画一条不断下降的曲线。前者忠实保留信息，后者可能让读者误以为所有数字来自同一标准测试。腹部和乳房观察也不能直接验证讲者关于肋间神经、迷走神经与全部内脏功能的模型。[8.28-17]

### 复习与应用

当看到“颜色浅了”“不那么胀了”“压着不痛了”时，先明确它属于哪一层指标，再问还需要什么资料才能回答真正的健康问题。

# 盆底与排尿：三个问题，一条协调链

8.28末尾开始的排尿主题，在8.29继续演示并系统复盘。主线可以整理为“储存→感知充盈→选择时机→协调排出”。尿意、控尿和排空是相关而不同的结果；一个环节的主观变化，不能替代其他环节的测量。[8.28-22][8.28-23][8.28-24][8.29-13]

**尿意**

此刻想不想排尿、感觉多强。与饮水、上次排尿和环境有关，不等于实际尿量。

**控尿**

是否发生不自主漏出，发生在咳嗽/跳跃还是强烈急迫感时。需要具体次数和情境。

**排空**

能否顺利启动、尿流如何、是否排尽。主观不尽感与实际残余尿是不同信息。

| 表现 | 重点记录 | 课堂结果应怎样理解 |
| --- | --- | --- |
| 咳嗽或跳跃漏尿 | 活动情境、是否真的漏出、影响程度 | 这是任务相关表现，不能用操作后尿意下降替代。[8.29-02] |
| 尿急/尿频 | 急迫程度、频次、间隔、是否伴漏出 | 8.28有约8–9分降到2–3分的口述，仅说明当时尿意变化。[8.28-23] |
| 尿不尽/排尿困难 | 启动、尿流、排尿后感觉及相关检查 | 不能当场排尿时，排空结果应记“尚未测到”。[8.29-02] |
| 术后尿意减弱 | 手术类型/时间、充盈感、排尿习惯、检查 | 不能仅从旧疤或触感推定病因。[8.29-07] |
| 下坠或肛周不适 | 坠胀、痒、痛、组织检查与病史分别写 | 感觉收紧不能证明痔疮、脱垂等结构问题消失。[8.29-03][8.29-12] |
| 训练与处理选择 | 明确类型、目标、耐受与后续指标 | 整体看待感觉和协调，并不否定盆底肌训练的价值。[8.29-01][8.29-13][E03] |

**储存** 膀胱充盈与控尿 → **感知** 记录尿意和情境 → **协调** 选择时机并排出 → **复盘** 尿意、漏尿、排空各自评价

### 把这些内容连起来

整理补充：这条协调链是功能示意，不是从体表按到某个脊髓节段的路线图。皮肤、椎骨、神经根和脊髓节段不可混为一谈。现有课堂没有连续漏尿次数、残余尿或长期对照资料，因而不能把“一次不想尿了”写成尿失禁已治愈。[8.28-23][8.29-08] NIDDK的治疗说明强调按类型与原因选择方案。[E03]

### 复习与应用

一份排尿观察表可设：时间、饮水、尿意强度、是否排尿、是否漏出、触发情境、不尽感。它帮助描述问题；具体检测及处理仍按需要进行。

# 性健康与身体接纳：以本人体验为中心

课程以兴奋、持续、高潮、消退四阶段组织性健康内容，并连接触觉、局部感觉和身体状态。阶段图有助于表达困扰，但不是人人必须完成的固定顺序或时长。健康判断应围绕本人是否困扰、是否疼痛、是否自愿，以及身体和关系背景。[8.29-04][8.29-06][E05]

**意愿与需求**

欲望和频率可以不同。尊重拒绝、允许改变决定；关系中的强迫不能被解释成被迫者体能或神经有问题。

**舒适与功能**

疼痛、干涩、胀感和触觉分别描述；某种偏好、较长准备时间或不愿触碰不自动意味着疾病。

**接纳与支持**

身体观察和镜像可以作为课程体验来理解，须尊重本人选择。外观不满意不能被写成疾病的责任。

| 观察维度 | 有帮助的问题 | 需要避免的简化 |
| --- | --- | --- |
| 欲望与兴奋 | 在什么情境下愿意或不愿意？是否因此困扰？ | 不以固定分钟数或频率判断神经损伤。[8.29-04][8.29-06] |
| 润滑、疼痛与舒适 | 痛在哪里、何时出现，是否与手术、阶段或药物有关？ | 不能把干涩与疼痛统一归因于心肺弱。[8.29-11][8.29-12] |
| 高潮与恢复 | 本人如何描述，有无满意或不适，期待是什么？ | 不用最大心率、统一时长或某一种表现打分。[8.29-04][8.29-10] |
| 局部触觉 | 痛、痒、坠胀、舒适和无明显感觉分开 | 没有愉悦不等于某条神经损坏；不同人的结果不混算。[8.29-05][8.29-09] |
| 关系与同意 | 双方的愿望、拒绝与安全是否受到尊重？ | 次数不同不决定谁有病，也不产生配合义务。[8.29-07] |
| 术后与身体形象 | 手术背景、动作、感觉、本人愿意面对什么？ | 不强迫观看或触摸，不把自我接纳写成治疗疾病的必要条件。[8.29-22][8.29-23] |

**说明本人困扰** → **定位发生环节** → **理解背景** → **选择支持**

不预设正常答案 | 欲望、舒适、疼痛等 | 身体、药物、关系与经历 | 尊重意愿，按问题评估

### 把这些内容连起来

外部核对：ACOG将欲望、唤起、高潮、性疼痛及药物相关问题分别讨论，也指出这些问题可能重叠。欲望可能在互动开始后出现，身体、情绪、关系和生活状态均可参与。[E05] 课堂的神经名称和脑影像可作为查证索引，但原图、论文与节段有缺失，不能直接推出外部手法的疗效。[8.29-05][8.29-10]

**复习与应用**

复习时用中性语言重述一个困扰，说明本人希望怎样改变；再区分哪些是体验、哪些是讲者推测、哪些仍需其他资料。

# 跨文件案例：看见连续过程与不同结局

案例的完整性来自清楚的过程与限制，而非只保留最后一句“好了”。下面将三天中的关键案例重新串联，保留改善、未改善、条件变化及随访缺口；个案均作匿名主题索引，不保留身份或可识别的私人细节。

**不跨人拼接**

相邻段落可能换了参与者。某人睡得好，不能补作另一位情绪个案的随访。

**不跨指标替代**

身体清晰度、自信、疼痛和对某事件的情绪，是不同分数。

**不跨时间承诺**

现场舒服、次日自述、稳定长期效果属于不同证据层级。

| 连续案例 | 过程与实际反馈 | 最值得学到什么 |
| --- | --- | --- |
| 多症状个案 | 紧张、腹胀与肩部不适分别记录；初段腹胀减轻而肩部未明确改变，后段再有改善自述。[8.27-17][8.27-18] | 分项复测比一个总体“有效”更清楚。 |
| 尾骨痛与原有神经痛 | 练习后曾加重；调整支持后部分尾骨反馈减轻，当天收尾仍有不适。[8.27-18][8.27-19][8.27-25][8.27-26] | 原有胸背神经痛没有明确改善证据，不能由尾骨反馈代替。 |
| 持续腹部不适 | 从时间线、用药与胀感入手；多种姿势/支持后评分下降。[8.27-24][8.27-25] | 条件改变需要随分数保留，不画伪精确疗效曲线。 |
| 情绪与身体案例 | 清晰度约2→6，自信约4–5→7；部分身体不适减轻，对事件的情绪仍复杂。[8.28-06][8.28-07] | 身体变舒服不等于创伤或关系问题已解决。 |
| 消化练习反馈 | 有即时减轻，也出现更胀、更硬和反复操作后的不适。[8.28-16][8.28-19][8.28-21] | 负面结果进入同一张表，不能都归为操作不到位。 |
| 长期步态困扰 | 先核对诊断来源，再比较主动/被动，加入分级动作、镜像与注意反馈。[8.29-17][8.29-18][8.29-19] | 多种方法同时出现，且缺后续功能评价，不能确定单独疗效。 |
| 头眼与节拍练习 | 有腰部轻松、踏实感，也有残余不适、眼酸、手抖与烦躁。[8.29-16][8.29-21] | 完成程度和耐受均重要，不能把疲劳直接解释为脑区被修复。 |

**从主诉出发** → **串联各文件** → **并列所有结果** → **写明结论上限**

分清谁与什么问题 | 保留每阶段条件 | 改善、未改、加重 | 持续性与机制未知

### 把这些内容连起来

整理补充：案例表可以向两边展开。向前补病史、目标和基线，向后补生活功能、持续性及后续求助。当前资料主要停留在现场，因此完整记录的表现是明确留出缺口，而不是用课堂预测填满缺口。

**复习与应用**

试着为一例写出“本次观察支持什么”和“本次观察尚不能支持什么”。两句话都应能回到具体文件。

# 把课程串成可复习、可讨论的知识体系

学习的落点是能解释一个问题、说清一份观察，并知道哪些内容还需要查证。把运动、身体感受和具体健康主题连接起来时，保留各自的指标和适用条件，避免形成“所有问题都归于同一神经机制”的总公式。[8.27-01][8.29-12][8.29-13]

**概念复习**

用一句话定义术语，再给一个案例；遇到定义不清或原图缺失，回到出处而不补造。

**案例复盘**

按“问题—条件—反馈—缺口”整理；将不适和未改善与改善放在一起。

**应用讨论**

先明确目标，再谈任务和负荷；区分课程学习、一般活动与需要专门评估的问题。

| 综合主题 | 可以保留的理解 | 需要校正或继续查证 |
| --- | --- | --- |
| 运动安排 | 类型、强度、时长、频率和恢复要具体。[8.27-05][8.27-06] | 一般指南与4×4等高强度框架分开；不要求人人冲击最大心率。[8.29-20][E02][E09] |
| 平衡与心率 | 支撑面、姿势、视线和任务难度都影响负荷。[8.29-14] | 穿戴读数与真实不适分别核查，不直接诊断前庭病变。 |
| 饮食限制 | 询问具体食物、症状和时间关联。[8.27-14] | 不从失衡方向、皮肤或性格要求普遍戒食；食物IgG不能诊断过敏。[E07] |
| 补充剂与抗衰 | 保留为待查话题，不组成统一保健清单。[8.29-11][8.29-19] | 不能从个人经历、价格或简单机制解释推导普遍效果。 |
| 产品与手法 | 记录成分/参数是否明确、过程和反馈。[8.28-21][8.29-07] | 原文缺少独立比较资料，不能以用量不足解释全部失败。 |
| 身体接纳与差异 | 尊重本人体验、正常外观差异及拒绝接触的权利。[8.28-18][8.29-23] | 不把疾病、亲密偏好或情绪困扰归责于“不爱自己”。 |
| 片段与转写 | 课间、短答、指代不清的内容保留索引。[8.27-07][8.27-23][8.28-20] | 没有完整信息时不扩写新理论，也不编造时间戳。 |

**选一个问题** 清楚表达学习目标 → **找对应概念** 用表格说明差别 → **连读一个案例** 保留过程与条件 → **形成复盘记录** 写出来源和待解问题

### 把这些内容连起来

自测清单：①区分触觉、本体感觉、内感知与身体意象；②区分睡眠困难的不同模式；③说明月经记录为何要带时间线；④区分尿意、漏尿与排空；⑤解释感受改善为何不等于组织修复；⑥说清同意与个人意愿在课堂观察中的位置。

**复习与应用**

最后形成一页个人学习图：中心写当前问题，四周依次放概念、案例、可观察指标和待查证问题。每一项附文件编号，下一次复习便能从问题回到具体材料。

# 课程出处索引

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.27-01] 课程导入与学习路径**

独立PDF：01_课程导入与学习路径_笔记与原文.pdf
8.27/1.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第3页

**[8.27-02] 女性生命阶段与身体感受**

独立PDF：02_女性生命阶段与身体感受_笔记与原文.pdf
8.27/2.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第7页

**[8.27-03] 身体知觉与神经科学框架**

独立PDF：03_身体知觉与神经科学框架_笔记与原文.pdf
8.27/3.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第11页

**[8.27-04] 自主神经与症状表达**

独立PDF：04_自主神经与症状表达_笔记与原文.pdf
8.27/4.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第15页

**[8.27-05] 血糖指标与运动安排**

独立PDF：05_血糖指标与运动安排_笔记与原文.pdf
8.27/5.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第19页

**[8.27-06] 运动剂量与身体调节**

独立PDF：06_运动剂量与身体调节_笔记与原文.pdf
8.27/6.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第23页

**[8.27-07] 课间交流片段**

独立PDF：07_课间交流片段_笔记与原文.pdf
8.27/7.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第27页

**[8.27-08] 学习负荷与自主神经**

独立PDF：08_学习负荷与自主神经_笔记与原文.pdf
8.27/8.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第29页

**[8.27-09] 安全感、进食与触觉反馈**

独立PDF：09_安全感、进食与触觉反馈_笔记与原文.pdf
8.27/9.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第33页

**[8.27-10] 身体位置感与镜像观察**

独立PDF：10_身体位置感与镜像观察_笔记与原文.pdf
8.27/10.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第37页

**[8.27-11] 闭眼身体感受的课堂记录**

独立PDF：11_闭眼身体感受的课堂记录_笔记与原文.pdf
8.27/11.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第41页

**[8.27-12] 身体感受反馈与个案筛选**

独立PDF：12_身体感受反馈与个案筛选_笔记与原文.pdf
8.27/12.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第45页

# 课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.27-13] 前庭相关演示与复测**

独立PDF：13_前庭相关演示与复测_笔记与原文.pdf

8.27/13.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第48页

**[8.27-14] 前庭训练问答与饮食争议**

独立PDF：14_前庭训练问答与饮食争议_笔记与原文.pdf

8.27/14.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第52页

**[8.27-15] 练习反馈与难度调整**

独立PDF：15_练习反馈与难度调整_笔记与原文.pdf

8.27/15.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第56页

**[8.27-16] 平衡反应与发育反射导入**

独立PDF：16_平衡反应与发育反射导入_笔记与原文.pdf

8.27/16.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第59页

**[8.27-17] 多症状个案与初步复测**

独立PDF：17_多症状个案与初步复测_笔记与原文.pdf

8.27/17.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第63页

**[8.27-18] 开合动作示范与新个案**

独立PDF：18_开合动作示范与新个案_笔记与原文.pdf

8.27/18.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第67页

**[8.27-19] 尾骨痛个案的连续观察**

独立PDF：19_尾骨痛个案的连续观察_笔记与原文.pdf

8.27/19.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第71页

**[8.27-20] 三类演示的课堂复盘**

独立PDF：20_三类演示的课堂复盘_笔记与原文.pdf

8.27/20.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第75页

**[8.27-21] 复测原则与辅助边界**

独立PDF：21_复测原则与辅助边界_笔记与原文.pdf

8.27/21.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第78页

**[8.27-22] 成人与儿童训练的区别**

独立PDF：22_成人与儿童训练的区别_笔记与原文.pdf

8.27/22.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第82页

**[8.27-23] 下颌功能问答片段**

独立PDF：23_下颌功能问答片段_笔记与原文.pdf

8.27/23.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第84页

**[8.27-24] 感觉分类与腹胀个案导入**

独立PDF：24_感觉分类与腹胀个案导入_笔记与原文.pdf

8.27/24.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第86页

# 课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.27-25] 腹部不适与枕下手法案例**

独立PDF：25_腹部不适与枕下手法案例_笔记与原文.pdf
8.27/25.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第90页

**[8.27-26] 个案复测与当天收尾**

独立PDF：26_个案复测与当天收尾_笔记与原文.pdf
8.27/26.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第94页

**[8.28-01] 内分泌系统与月经调节**

独立PDF：01_内分泌系统与月经调节_笔记与原文.pdf
8.28/1(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第4页

**[8.28-02] 月经记录、压力与甲状腺**

独立PDF：02_月经记录、压力与甲状腺_笔记与原文.pdf
8.28/2(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第8页

**[8.28-03] 检查结果与课堂应用边界**

独立PDF：03_检查结果与课堂应用边界_笔记与原文.pdf
8.28/3(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第12页

**[8.28-04] 压力反馈与身心调节问答**

独立PDF：04_压力反馈与身心调节问答_笔记与原文.pdf
8.28/4(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第16页

**[8.28-05] 感觉输入、疼痛与闸门理论**

独立PDF：05_感觉输入、疼痛与闸门理论_笔记与原文.pdf
8.28/5(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第20页

**[8.28-06] 情绪与身体个案的基线记录**

独立PDF：06_情绪与身体个案的基线记录_笔记与原文.pdf
8.28/6(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第24页

**[8.28-07] 枕下案例的反馈与练习问题**

独立PDF：07_枕下案例的反馈与练习问题_笔记与原文.pdf
8.28/7(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第28页

**[8.28-08] 分组练习反馈与概念衔接**

独立PDF：08_分组练习反馈与概念衔接_笔记与原文.pdf
8.28/8(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第32页

**[8.28-09] 本体感觉与睡眠觉醒基础**

独立PDF：09_本体感觉与睡眠觉醒基础_笔记与原文.pdf
8.28/9(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第35页

**[8.28-10] 睡眠主诉与情绪个案访谈**

独立PDF：10_睡眠主诉与情绪个案访谈_笔记与原文.pdf
8.28/10(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第39页

# 课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.28-11] 压力模型与个体资源**

独立PDF：11_压力模型与个体资源_笔记与原文.pdf

8.28/11(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第43页

**[8.28-12] 颈部感觉、咳嗽与声音反馈**

独立PDF：12_颈部感觉、咳嗽与声音反馈_笔记与原文.pdf

8.28/12(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第47页

**[8.28-13] 颈部练习的边界与异常反馈**

独立PDF：13_颈部练习的边界与异常反馈_笔记与原文.pdf

8.28/13(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第51页

**[8.28-14] 从颈部练习转向消化问题**

独立PDF：14_从颈部练习转向消化问题_笔记与原文.pdf

8.28/14(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第55页

**[8.28-15] 上腹不适的问诊与位置描述**

独立PDF：15_上腹不适的问诊与位置描述_笔记与原文.pdf

8.28/15(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第58页

**[8.28-16] 腹部触碰示范与胸壁感觉**

独立PDF：16_腹部触碰示范与胸壁感觉_笔记与原文.pdf

8.28/16(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第62页

**[8.28-17] 内脏感觉模型与乳房观察**

独立PDF：17_内脏感觉模型与乳房观察_笔记与原文.pdf

8.28/17(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第66页

**[8.28-18] 乳晕变化、哺乳与比较方法**

独立PDF：18_乳晕变化、哺乳与比较方法_笔记与原文.pdf

8.28/18(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第70页

**[8.28-19] 肋间练习片段与复测提醒**

独立PDF：19_肋间练习片段与复测提醒_笔记与原文.pdf

8.28/19(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第74页

**[8.28-20] 分组交流与上课前过渡**

独立PDF：20_分组交流与上课前过渡_笔记与原文.pdf

8.28/20(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第76页

**[8.28-21] 反应差异与效果持续性**

独立PDF：21_反应差异与效果持续性_笔记与原文.pdf

8.28/21(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第79页

**[8.28-22] 储尿与排尿的基础框架**

独立PDF：22_储尿与排尿的基础框架_笔记与原文.pdf

8.28/22(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第83页

# 课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.28-23] 尿意即时变化与解剖说明**

独立PDF：23_尿意即时变化与解剖说明_笔记与原文.pdf

8.28/23(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第87页

**[8.28-24] 排尿主题复盘与课程收尾**

独立PDF：24_排尿主题复盘与课程收尾_笔记与原文.pdf

8.28/24(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第91页

**[8.29-01] 课前反馈与排尿主题导入**

独立PDF：01_课前反馈与排尿主题导入_笔记与原文.pdf

8.29/1.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第3页

**[8.29-02] 排尿症状与骶部演示**

独立PDF：02_排尿症状与骶部演示_笔记与原文.pdf

8.29/2.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第6页

**[8.29-03] 瘢痕与肛周不适个案**

独立PDF：03_瘢痕与肛周不适个案_笔记与原文.pdf

8.29/3.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第10页

**[8.29-04] 性反应周期与个体差异**

独立PDF：04_性反应周期与个体差异_笔记与原文.pdf

8.29/4.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第14页

**[8.29-05] 盆底感觉与神经术语梳理**

独立PDF：05_盆底感觉与神经术语梳理_笔记与原文.pdf

8.29/5.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第18页

**[8.29-06] 课间反馈与性健康问答**

独立PDF：06_课间反馈与性健康问答_笔记与原文.pdf

8.29/6.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第21页

**[8.29-07] 关系需求与术后尿意问答**

独立PDF：07_关系需求与术后尿意问答_笔记与原文.pdf

8.29/7.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第24页

**[8.29-08] 腰腹区域演示与定位疑点**

独立PDF：08_腰腹区域演示与定位疑点_笔记与原文.pdf

8.29/8.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第28页

**[8.29-09] 分组练习与会阴感觉复盘**

独立PDF：09_分组练习与会阴感觉复盘_笔记与原文.pdf

8.29/9.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第32页

**[8.29-10] 感觉影像与性功能课堂总结**

独立PDF：10_感觉影像与性功能课堂总结_笔记与原文.pdf

8.29/10.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第36页

# 课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.29-11] 疼痛问答与训练适配**

独立PDF：11_疼痛问答与训练适配_笔记与原文.pdf

8.29/11.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第40页

**[8.29-12] 课程设计与盆底问题收束**

独立PDF：12_课程设计与盆底问题收束_笔记与原文.pdf

8.29/12.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第44页

**[8.29-13] 泌尿系统的整体复盘**

独立PDF：13_泌尿系统的整体复盘_笔记与原文.pdf

8.29/13.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第48页

**[8.29-14] 运动心率与平衡负荷**

独立PDF：14_运动心率与平衡负荷_笔记与原文.pdf

8.29/14.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第52页

**[8.29-15] 身体重心感知与背部紧张**

独立PDF：15_身体重心感知与背部紧张_笔记与原文.pdf

8.29/15.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第56页

**[8.29-16] 头眼配合演示的反馈与细节**

独立PDF：16_头眼配合演示的反馈与细节_笔记与原文.pdf

8.29/16.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第60页

**[8.29-17] 长期步态困扰个案的开始**

独立PDF：17_长期步态困扰个案的开始_笔记与原文.pdf

8.29/17.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第64页

**[8.29-18] 分级动作与身体感受练习**

独立PDF：18_分级动作与身体感受练习_笔记与原文.pdf

8.29/18.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第68页

**[8.29-19] 个案收尾与抗衰话题**

独立PDF：19_个案收尾与抗衰话题_笔记与原文.pdf

8.29/19.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第71页

**[8.29-20] 运动建议与感觉敏感话题**

独立PDF：20_运动建议与感觉敏感话题_笔记与原文.pdf

8.29/20.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第75页

**[8.29-21] 手指节拍练习与不同反馈**

独立PDF：21_手指节拍练习与不同反馈_笔记与原文.pdf

8.29/21.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第79页

**[8.29-22] 关节弹响与术后身体感受**

独立PDF：22_关节弹响与术后身体感受_笔记与原文.pdf

8.29/22.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第82页

# 课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

**[8.29-23] 身体接纳与课程收尾问答**

独立PDF：23_身体接纳与课程收尾问答_笔记与原文.pdf

8.29/23.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第86页

# 外部核对与阅读说明

### [E01] IASP｜疼痛定义与术语

疼痛是个人体验，不能仅从组织或神经信号推断。

https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/

### [E02] WHO｜身体活动与久坐指南

一般成人有氧及肌力活动建议；不等于个体运动处方。

https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789240014886

### [E03] NIDDK｜尿失禁的治疗

按类型及原因选择处理，盆底肌训练是治疗选项之一。

https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/bladder-control-problems/treatment

### [E04] NIDCD｜平衡障碍

平衡涉及多个系统，评估和康复应个体化。

https://www.nidcd.nih.gov/health/balance-disorders

### [E05] ACOG｜女性性健康

欲望、唤起、高潮及疼痛问题可相互重叠，并受多种因素影响。

https://www.acog.org/womens-health/faqs/your-sexual-health

### [E06] NHS｜月经

周期存在个体差异，变化需联系本人模式和相关症状。

https://www.nhs.uk/conditions/periods/

### [E07] AAAAI｜食物IgG检测

食物IgG不能据以诊断食物过敏或不耐受。

https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/igg-food-test

### [E09] NTNU CERG｜运动建议与4×4间歇

相关4×4框架采用85%至95%最大心率，不要求达到100%。

https://www.ntnu.edu/cerg/advice

## 整理口径

课程模型用于准确呈现讲者的思路；课堂观察只说明现场发生的变化；整理补充用于解释联系与阅读方法；外部核对以E编号标注。图中的箭头表示概念关系或复盘顺序，不自动代表已经证实的生理因果。依赖现场图像的手法不从残缺转写补成操作教程。

引用说明：以客户提供的课程标题与日期归档。课堂来源指向已生成的结构化笔记；外部核对仅用于对应基础知识与关键边界，不表示相关机构认可课堂技术。没有可统一核验的录音时间戳，因此不编造分钟定位。

版本：2026-10-30。8.15的11号文件已补齐；全部118份材料均完成通读与主题映射。原始资料未改动，公开版不附原文、个人身份或私人经历细节。